

ЧЕКЛИСТ

Неврологический осмотр

Последовательность и критерии оценки на догоспитальном этапе

Порядок осмотра: время начала симптомов и глюкоза, сознание, очаговый дефицит, топика.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Время начала и лекарственный анамнез

1. Время появления симптомов фиксируется с точностью до часа и минуты. Если дефицит обнаружен при пробуждении, записывается время, когда пациента в последний раз видели без неврологического дефицита (last known well). От этой точки отсчитывается терапевтическое окно тромболизиса и определяется стационар маршрутизации.
2. Изменения лекарственной терапии за последние дни: гипотензивные средства, антикоагулянты, гипогликемические препараты, психотропные средства. Названия и дозы переписываются с упаковок.

Глюкоза

Гипогликемия воспроизводит гемипарез, афазию, кому, психоз, головокружение и судороги. Измерение выполняется до интерпретации неврологического статуса. Некорректированная гипогликемия вызывает необратимое повреждение головного мозга.

Осмотр без глюкометрии не является завершённым неврологическим осмотром.

Сознание

- AVPU — для быстрой ориентировки; шкала комы Глазго (ШКГ) — для карты вызова: открывание глаз (1–4), речевая реакция (1–5), двигательная реакция (1–6).
- Интерпретация суммы: 15 — ясное сознание; 14–13 — оглушение; 12–9 — сопор; 8–3 — кома.
- Головокружение в ШКГ не учитывается. При афазии, не связанной с угнетением сознания, компоненты описываются словами, без формального балла.

Речь

- Дизартрия (нарушение артикуляции при сохранённом подборе слов) — поражение ствола, мозжечка или мимической мускулатуры.
- Афазия (нарушение понимания, поиска слов или беглая, но бессодержательная речь) — кора доминантного полушария.
- Минимальный набор проб: назвать три предмета, повторить фразу, выполнить трёхступенчатую команду.

Черепные нервы

Нерв	Проба	Патологические находки
II	Зрачки на свет; поля зрения конfrontационным методом по четырём квадрантам	Гемианопсия, анизокория
III, IV, VI	Слежение в шести направлениях; наличие диплопии	Парез взора, диплопия, косоглазие
V	Прикосновение в трёх зонах лица; тонус жевательных мышц	Асимметрия чувствительности
VII	Улыбка, оскал, поднятие бровей, зажмуривание	Центральный парез: нижняя треть лица. Периферический парез (Белла): вся половина лица, включая бровь и глазную щель
VIII	Шёпотная речь у уха; нистагм	Остро возникшая односторонняя тугоухость в сочетании с головокружением указывает на поражение в бассейне AICA
IX, X	Фонация «а-а-а», положение язычка, глоток воды	Отклонение язычка, поперхивание, дисфагия
XI	Поворот головы и подъём плеч против сопротивления	Асимметрия силы
XII	Высовывание языка	Отклонение от средней линии

Сила: шкала MRC (0-5)

Балл	Критерий
5	Полный объём движения против максимального сопротивления
4	Движение против сопротивления, сила снижена
3	Движение против силы тяжести, сопротивление не преодолевается
2	Движение в плоскости, сила тяжести не преодолевается
1	Видимое сокращение без движения
0	Сокращения нет

Оценка симметричная, по группам: сжатие кисти, сгибание и разгибание в локте, отведение плеча, тыльное и подошвенное сгибание стопы, подъём ноги. Проба Барре: руки под 90° сидя или под 45° лёжа в течение 10 с; пронация и опускание одной руки выявляются раньше, чем разница при сопротивлении.

Сохранённая сила не исключает инсульт: поражение мозжечка нарушает координацию, а не мышечную силу.

Тонус, рефлексы, патологические знаки

- Тонус: спастичность (феномен складного ножа), ригидность, гипотония.
- Сухожильные рефлексы (двуглавая, коленный, ахиллов): диагностически значима асимметрия, а не абсолютная величина.
- Симптом Бабинского: разгибание I пальца стопы при штриховом раздражении подошвы — признак поражения пирамидного пути.

Координация и равновесие

- Пальце-носовая проба с закрытыми глазами; проба пятка-колени.
- Диадохокinesis (быстрая пронация-супинация).
- Проба Ромберга; при сохранном выполнении — сенсibilизированный Ромберг (стопы в одну линию) и тандемная походка.
- Неспособность сидеть или стоять без поддержки указывает на поражение ствола или мозжечка.

Чувствительность

- Сравнение симметричных зон сверху вниз.
- При подозрении на спинальный уровень определяется и записывается граница по дерматомам.
- Седловидная анестезия в сочетании с задержкой или недержанием мочи соответствует синдрому конского хвоста. Необратимые изменения развиваются в течение часов; показана немедленная эвакуация в стационар с нейрохирургической помощью.

Менингеальные знаки

Оцениваются при головной боли, рвоте, лихорадке и нарушении сознания:

- ригидность затылочных мышц;
- симптом Кернига, симптомы Брудзинского;
- светобоязнь, гипераккузия, вынужденная поза.

Отсутствие менингеальных знаков не исключает ни менингит, ни субарахноидальное кровоизлияние. Знаки могут отсутствовать у пожилых, при глубокой коме и в первые часы субарахноидального кровоизлияния.

Шкала LAMS и маршрутизация

Шкала моторного дефицита LAMS (Los Angeles Motor Scale) — приложение 19 Алгоритмов оказания скорой медицинской помощи, Москва, 2025.

Признак	Баллы
Лицевая мускулатура: асимметрии нет или она минимальна	0
Частичный или полный паралич нижней трети лица с одной стороны либо отсутствие движений верхней и нижней половины лица с одной стороны	1
Удержание рук: удерживаются под 90° или 45° без опускания	0
Одна рука медленно опускается, сопротивление силе тяжести сохранено	1
Рука быстро падает без сопротивления	2
Сжатие кисти: симметрично, сила не снижена	0
С одной стороны слабее	1
Не сжимает или движения минимальны	2

Техника. Лицо: оскал, поднятие бровей, зажмуривание; при речевых расстройствах оценивается симметрия болевой гримасы. Руки: вытянуть под 90° сидя или под 45° лёжа; болевые стимулы не наносятся. Кисть: сжатие указательного и среднего пальцев исследующего, сравнение сторон.

Сумма 0–5. При сопоре или коме баллы не определяются; в карте указывается степень угнетения сознания.

Маршрутизация:

- LAMS ≥ 4 и время от начала заболевания ≤ 4 ч — стационар инсультной сети;
- LAMS < 4 , либо сопор или кома, либо время от начала > 4 ч — ближайший стационар с отделением для лечения ОНМК.

Терапия (Алгоритмы СМП, Москва, 2025)

- Положение с приподнятым на 30° изголовьем.
- SpO₂ ≤ 93 % — ингаляция кислорода.
- Урапидил 12,5–25 мг (2,5–5 мл) внутривенно медленно только при САД > 200 мм рт. ст. (инфаркт мозга) или > 180 мм рт. ст. (субарахноидальное или внутримозговое кровоизлияние). Снижение САД не более 15 % от исходного.
- САД < 100 мм рт. ст. — натрия хлорид 0,9 % 250–500 мл внутривенно капельно.
- ЧСС ≥ 100 в минуту — пропранолол 10–20 мг или метопролол 12,5–25 мг внутрь при отсутствии противопоказаний.
- Рвота — метоклопрамид 10 мг (2 мл) внутривенно. Головная боль — кеторолак 30 мг внутривенно. Температура тела > 38 °C — метамизол натрия 1000 мг (2 мл) внутривенно.
- Магния сульфат 2500 мг (10 мл) в 250 мл растворителя внутривенно капельно, 30–60 капель в минуту; этилметилгидроксипиридина сукцинат 250 мг (5 мл) внутривенно.

Признаки, требующие немедленной эвакуации

- Триада Кушинга (артериальная гипертензия, брадикардия, нерегулярное дыхание) — внутричерепная гипертензия. Системное артериальное давление не снижается.
- Внезапно возникшая максимально интенсивная головная боль, рвота, менингеальные знаки — субарахноидальное кровоизлияние.
- Боль в шее или лице в сочетании с синдромом Горнера и очаговой неврологической симптоматикой — диссекция позвоночной или внутренней сонной артерии. Ротационные пробы шеи и HINTS не выполняются.
- Светлый промежуток после травмы головы — эпидуральная гематома.
- Задержка мочи и седловидная анестезия — синдром конского хвоста.
- Анизокория при угнетении сознания — вклинение.
- Однотипные головная боль и тошнота у нескольких членов семьи — отравление оксидом углерода.
- Прогрессирующее угнетение сознания у пациента с алкогольным опьянением не объясняется опьянением; исключается черепно-мозговая травма.

Документирование

В карту вызова вносятся: время начала симптомов или last known well; ШКГ по компонентам; LAMS с разбивкой баллов; глюкоза; артериальное давление на обеих руках при подозрении на диссекцию; температура тела; SpO₂; ЭКГ; лекарственные препараты; стационар и время передачи; кому передан пациент.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи, Москва, 2025 — раздел «Неврология» (G45, G45.0, инсульт, ТИА, вертебробазилярная недостаточность), приложение 19 (шкала LAMS), приложение по шкале комы Глазго.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — Neurological emergencies, Stroke.
- Tintinalli's Emergency Medicine — Stroke syndromes, Spinal cord emergencies.